Trabajo de parto · Guía práctica para la ECOE

Estación de procedimiento: atención del parto eutócico en simulador · Segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. UI: unidades internacionales. IM e IV: vías intramuscular e intravenosa. FCF: frecuencia cardiaca fetal. FC: frecuencia cardiaca materna. HPP: hemorragia posparto. RPBI: residuos peligrosos biológico-infecciosos. GPC: guía de práctica clínica IMSS-052-19 de vigilancia y atención amigable del trabajo de parto. NOM-007: NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. NOM-087: NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, sobre el manejo de los RPBI.

Índice

1 La estación y su rúbrica
- 1.1 Criterios que se califican
- 1.2 Secuencia de la estación

2 Preparación estéril
- 2.1 Vestimenta para el área de tococirugía
- 2.2 Lavado quirúrgico de manos en tres tiempos
- 2.3 Colocación de la bata
- 2.4 Guantes con técnica cerrada

3 Material, comunicación, asepsia y campos
- 3.1 Material
- 3.2 Comunicación con la mujer y consentimiento
- 3.3 Paso a la sala de expulsión
- 3.4 Asepsia
- 3.5 Campos estériles

4 Fundamento: mecanismo del parto

5 Periodo expulsivo
- 5.1 Pujo
- 5.2 Protección del periné
- 5.3 Episiotomía
- 5.4 Nacimiento de la cabeza
- 5.5 Rotación externa y circular de cordón
- 5.6 Hombros, cuerpo y oxitocina
- 5.7 Distocia de hombros

6 Recién nacido y cordón
- 6.1 Apego inmediato
- 6.2 Pinzamiento y corte del cordón
- 6.3 Entrega al pediatra y registro

7 Alumbramiento
- 7.1 Manejo activo y uterotónico
- 7.2 Signos de desprendimiento de la placenta
- 7.3 Extracción de la placenta
- 7.4 Mecanismos de Schultze y de Duncan
- 7.5 Revisión de la placenta

8 Cierre de la atención
- 8.1 Desecho de la placenta y de los demás residuos
- 8.2 Revisión del canal del parto
- 8.3 Si el sangrado es abundante
- 8.4 Vigilancia del puerperio inmediato

9 Escenarios para practicar

10 Preguntas directas con respuesta modelo

11 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

12 Contenido de segundo plano

13 Plan de estudio de dos días
Referencias

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 8 es una estación de procedimiento: se atiende un parto eutócico en un simulador, desde la entrada a la sala de expulsión hasta la revisión del canal del parto. Califica 21 criterios, cada uno como cumplido o no cumplido, sin medios puntos, y se acredita con 15 de 21.[1] De esta regla se desprenden tres consecuencias para preparar la estación:

- **Solo se pueden perder seis criterios.** No hay un criterio eliminatorio, pero la contaminación cuesta caro: los cuatro primeros criterios (vestimenta, lavado, bata y guantes) se califican “sin contaminarse”, y un solo error de técnica estéril puede costar varios puntos seguidos.
- **La mitad de la estación son pasos manuales que se dicen en voz alta.** El evaluador califica lo que ve y lo que el alumno anuncia: “protejo el periné”, “busco circular de cordón”, “indico 10 UI de oxitocina”.
- **Seis criterios piden conocimientos además de la maniobra:** las maniobras de protección del periné, las indicaciones de la episiotomía, el manejo de la distocia de hombros, los signos de desprendimiento de la placenta con el número de cotiledones, los mecanismos de Schultze y de Duncan, y la bolsa en la que se desecha la placenta.

Tabla 1. Criterios de la práctica 8 y respuesta esperada[1]

#	Criterio	Acción o respuesta esperada	Sección
1	Vestimenta para tococirugía	Gorro y botas, sin contaminarse	2.1
2	Lavado de manos	Lavado quirúrgico en tres tiempos	2.2
3	Bata	Colocación sin contaminarse	2.3
4	Guantes	Pedir el número correcto a enfermería; técnica cerrada sin contaminarse	2.4
5	Material	Dos pinzas para el cordón, riñón para la placenta, gasa montada para la asepsia, instrumentos de corte y hemostasia	3.1
6	Asepsia	Vulva, región suprapúbica, cara interna de los muslos y región glútea, “en calzoncillo”	3.4
7	Campos estériles	Campo inferior impermeable bajo la paciente, campo abdominal y pierneras	3.5
8	Protección del periné	Presión sobre el periné posterior; maniobras de Ritgen y finlandesa	5.2
9	Episiotomía	No rutinaria; lateral; indicaciones: periné corto, cara, parto instrumentado y pérdida del bienestar fetal	5.3

#	Criterio	Acción o respuesta esperada	Sección
10	Pujo	Pujar durante la contracción	5.1
11	Nacimiento de la cabeza	Mano izquierda en la cabeza y derecha para liberar la cara	5.4
12	Rotación externa	Acompañarla y buscar circular de cordón	5.5
13	Hombro anterior	Descenso suave con las palmas en la cabeza; indicar 10 UI de oxitocina	5.6
14	Hombro posterior y cuerpo	Movimiento hacia arriba y deslizar la mano por la espalda; distocia de hombros: McRoberts y presión suprapúbica	5.6 y 5.7
15	Apego	Recién nacido sobre la madre	6.1
16	Cordón	Pinzamiento tardío o inmediato, corte y entrega al pediatra	6.2 y 6.3
17	Alumbramiento	Signos de desprendimiento, tracción leve del cordón, torsión de las membranas y revisión de la placenta (15 a 20 cotiledones)	7.2 a 7.5
18	Uterotónico	10 UI de oxitocina	7.1
19	Tipos de alumbramiento	Schultze (80%) y Duncan (20%)	7.4
20	Residuos	Colocar la placenta en la bolsa correcta	8.1
21	Canal del parto	Revisar que no haya desgarros ni lesiones	8.2

Algunas respuestas de la rúbrica difieren de las guías vigentes (el tipo de episiotomía, el momento del uterotónico y el pinzamiento “inmediato”). La sección 11 muestra cómo decir la respuesta que se califica y la precisión en la misma frase.

1.2 Secuencia de la estación

La estación se divide en cuatro bloques que conviene ensayar siempre en el mismo orden:[1]

1. **Preparación estéril:** vestimenta, lavado quirúrgico, bata y guantes.
2. **Preparación del campo:** material, explicación a la mujer, asepsia y colocación de los campos.
3. **Expulsivo:** pujo, protección del periné, cabeza, rotación externa y circular de cordón, hombros con oxitocina, cuerpo, apego y cordón.
4. **Alumbramiento y cierre:** signos de desprendimiento, extracción y revisión de la placenta, uterotónico, desecho de la placenta, revisión del canal del parto y vigilancia del sangrado.

Durante toda la estación se habla con la mujer, aunque sea un simulador: se le explica cada paso antes de hacerlo y se le pide permiso para los procedimientos (sección 3.2).

2. Preparación estéril

2.1 Vestimenta para el área de tococirugía

Antes de entrar al área de tococirugía se colocan el gorro, que cubre todo el cabello, y las botas sobre el calzado, sin contaminarse.[1] El cubrebocas se coloca también antes del lavado, porque después las manos ya no pueden tocar la cara.

2.2 Lavado quirúrgico de manos en tres tiempos

El lavado quirúrgico por arrastre se hace con cepillo y jabón antiséptico, con las manos siempre por arriba de los codos para que el agua escurra de las manos hacia los codos y no al revés. Se retiran antes los anillos, las pulseras y el reloj.[2] Los tres tiempos recorren cada vez una superficie menor:[2]

1. **Primer tiempo:** uñas, dedos, espacios interdigitales, palma y dorso, y después el antebrazo y el codo, hasta unos 5 cm por arriba del pliegue del codo, con movimientos circulares; se repite en el otro brazo.
2. **Segundo tiempo:** desde las uñas hasta la unión del tercio medio con el tercio proximal del antebrazo, de forma alterna en ambos brazos.
3. **Tercer tiempo:** desde las uñas hasta la muñeca, de forma alterna.

Al terminar se entra a la sala con las manos por arriba de los codos y se secan con una compresa estéril desde los dedos hacia el codo, sin regresar. La duración total varía según el protocolo de cada institución. La OMS acepta como preparación quirúrgica tanto el lavado con jabón antimicrobiano como la fricción con una solución de base alcohólica.[2,3]

2.3 Colocación de la bata

La bata estéril se toma por el cuello, se deja desdoblar sin que toque nada, y se introducen ambos brazos en las mangas **sin sacar las manos de los puños**, porque la técnica cerrada de guantes exige que las manos queden dentro de ellos. Una persona del equipo circulante ajusta y ata la bata por detrás.[1,4]

2.4 Guantes con técnica cerrada

Se pide a enfermería el **número de guante correcto**, que corresponde a la talla de la mano.[1] Con la técnica cerrada, las manos permanecen dentro de las mangas de la bata durante todo el procedimiento:[4]

1. Con la mano cubierta por la manga, se coloca el guante sobre el puño de la bata del mismo lado, con la palma hacia abajo y los dedos del guante apuntando hacia el codo.
2. Desde el interior de la manga se sujeta el borde del guante y se lleva hacia la abertura del puño.

3. Se despliega el borde del guante para que cubra el puño elástico de la bata, y se introducen los dedos.
4. Se repite con la otra mano, usando la mano ya enguantada para ayudar.

Si hay contaminación, se anuncia y se cambia la prenda contaminada antes de continuar: es preferible perder tiempo a perder la técnica estéril.[1]

3. Material, comunicación, asepsia y campos

3.1 Material

La rúbrica pide comprobar el material completo antes de empezar:[1]

- **Dos pinzas** para pinzar el cordón umbilical, entre las cuales se corta.
- **Riñón:** el recipiente metálico en forma de riñón en el que se recibe y se revisa la placenta.
- **Gasa montada:** una gasa sujeta en una pinza, con la que se hace la asepsia sin tocar la piel con los guantes.
- **Instrumentos de corte y hemostasia:** tijeras para el cordón y la episiotomía, pinzas hemostáticas, portaagujas y sutura.

Conviene anunciar también que está preparada la **oxitocina de 10 UI** para el manejo activo del alumbramiento.[5,6]

3.2 Comunicación con la mujer y consentimiento

La GPC adopta el modelo de atención amigable de la OMS: una atención respetuosa, basada en evidencia, con el menor número de intervenciones innecesarias y que respeta la autonomía de la mujer.[5] En la estación se traduce en acciones concretas:

- **Presentarse y explicar:** decir el propio nombre y cargo, y explicar cada paso antes de hacerlo, con palabras sencillas.
- **Pedir permiso:** los procedimientos se hacen con el consentimiento de la mujer; una episiotomía sin indicación ni consentimiento se ajusta a la descripción de violencia obstétrica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.[6,7]
- **Respetar la posición y el acompañamiento:** se permite la posición que la mujer prefiera, incluida la vertical, y el acompañamiento continuo, por un familiar o por personal de salud, ofrece apoyo emocional, medidas de confort e información.[5,6]
- **No discriminar ni ejercer violencia:** la NOM-007 lo establece de forma expresa para toda persona que atienda a la mujer en trabajo de parto.[6]

3.3 Paso a la sala de expulsión

La mujer pasa a la sala de expulsión con dilatación y borramiento completos y con descenso de la presentación. Si el hospital tiene la infraestructura se favorece el parto vertical, en el que el torso forma un ángulo de 45 a 90 grados con la horizontal; si no, se permite la postura libre que la sala admita.[5] Antes del expulsivo se comprueban tres datos:

- **Posición de la cabeza:** los dedos recorren la sutura sagital y distinguen las fontanelas anterior y posterior; en caso de duda se usa el ultrasonido.[8]
- **FCF:** se ausculta al término de cada contracción, cada 5 minutos, durante todo el expulsivo.[5]
- **Vejiga:** la vejiga distendida puede obstaculizar el descenso; si la mujer no puede orinar, se coloca una sonda.[8]

Duración esperada del expulsivo. Su mediana es de unos 50 minutos en las nulíparas y de unos 20 en las multíparas, con gran variación. La OMS señala que el nacimiento suele ocurrir en las 3 horas siguientes a la dilatación completa en el primer parto y en las 2 horas siguientes en los demás.[8,9]

3.4 Asepsia

La asepsia se hace con la gasa montada, empezando por la vulva y siguiendo por la región suprapúbica, la cara interna de los muslos y la región glútea, de modo que la zona preparada tiene la forma de un “calzoncillo”.[1]

3.5 Campos estériles

Los campos se colocan en este orden:[1]

1. **Campo inferior impermeable**, por debajo de los glúteos de la paciente.
2. **Campo abdominal**, sobre el abdomen.
3. **Pierneras**, que cubren ambas piernas.

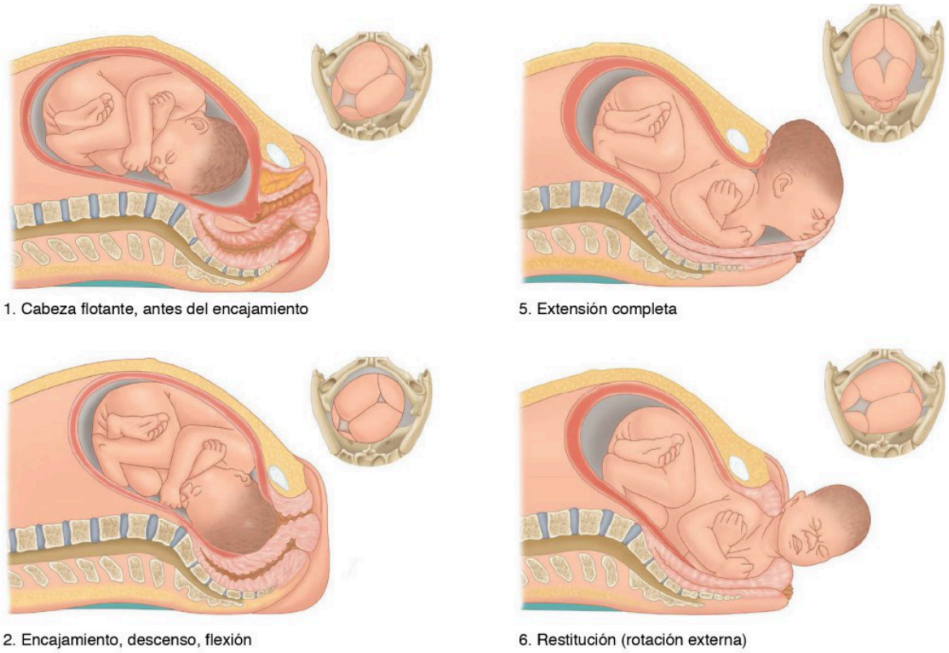
4. Fundamento: mecanismo del parto

Los pasos del expulsivo acompañan los **movimientos cardinales** con los que el feto atraviesa la pelvis: encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Los movimientos se superponen en el tiempo.[8]

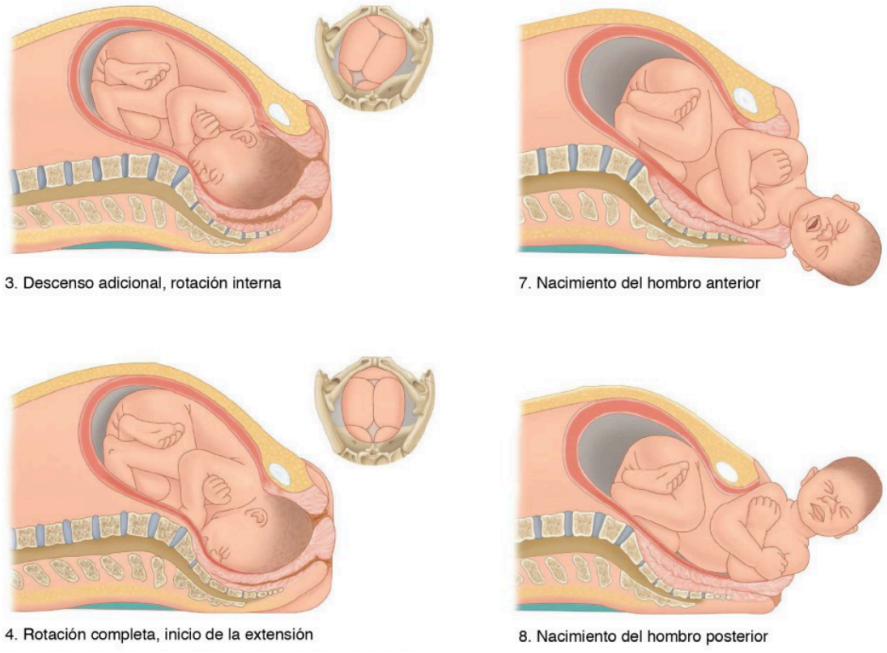
- **Extensión:** al llegar a la vulva, la base del occipucio se apoya en el borde inferior del pubis y, al distenderse el periné, nacen sucesivamente el occipucio, la frente, la nariz, la boca y el mentón. Es el momento de proteger el periné y de controlar la velocidad de salida de la cabeza.
- **Rotación externa (restitución):** la cabeza ya fuera gira hacia el lado en el que estaba el occipucio, mientras los hombros se alinean con el diámetro anteroposterior

del estrecho inferior, de modo que un hombro queda detrás del pubis y el otro es posterior.

- **Expulsión:** el hombro anterior aparece bajo el pubis, el posterior distiende el periné y el resto del cuerpo sale con rapidez. Si el hombro anterior se atora detrás del pubis, se diagnostica una distocia de hombros.



Movimientos cardinales del trabajo de parto desde una posición occipitoanterior izquierda (primera parte): 1, cabeza flotante antes del encajamiento; 2, encajamiento, descenso y flexión; 5, extensión completa; 6, restitución (rotación externa). Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-4).[8]



Movimientos cardinales (segunda parte): 3, descenso adicional y rotación interna; 4, rotación completa e inicio de la extensión; 7, nacimiento del hombro anterior; 8, nacimiento del hombro posterior. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-4).[8]

5. Periodo expulsivo

5.1 Pujo

La rúbrica pide ayudar a la paciente explicándole que debe pujar cuando siente la contracción.[1] El pujo de la mayoría de las mujeres es reflejo, y la GPC recomienda no dirigirlo de forma sistemática, porque dirigirlo no acortó el expulsivo ni redujo los desgarros graves. Cuando la mujer necesita orientación, se le pide pujar al inicio de la contracción, como para defecar, y descansar entre contracciones.[5,8]

La maniobra de Kristeller (presión sobre el fondo uterino) no se realiza: no redujo el parto instrumentado ni la cesárea, aumentó los desgarros cervicales, y la NOM-007 la prohíbe por sus riesgos para la madre y el feto.[5,6]

5.2 Protección del periné

La rúbrica espera que el alumno proteja el periné presionando el periné posterior y retrayéndolo hacia atrás para evitar lesiones, y que nombre las maniobras de Ritgen y finlandesa.[1] Estas técnicas tienen respaldo:

- **Maniobra de Ritgen modificada:** con una mano cubierta con una gasa se presiona el mentón fetal a través del periné, mientras la otra mano controla la velocidad de salida de la cabeza. Se asoció con menos desgarros de primer grado.[5]
- **Técnica finlandesa:** el pulgar y el índice de una mano comprimen el periné hacia la línea media para disminuir la tensión de la horquilla posterior, mientras la otra mano frena y flexiona la cabeza para que salga despacio y entre contracciones. Los estudios observacionales la asocian con menos lesiones del esfínter anal, pero su evidencia es de bajo nivel.[10]
- **Compresas calientes y masaje perineal:** la GPC recomienda las compresas calientes y la protección manual; el masaje perineal aumentó la probabilidad de un periné íntegro y redujo los desgarros de tercer y cuarto grado.[5]

5.3 Episiotomía

La rúbrica resume la episiotomía así: busca evitar los desgarros de tercer y cuarto grado; se recomienda lateral; no se realiza en mujeres sanas, porque se considera violencia obstétrica; sus indicaciones son el periné corto, la presentación de cara, el parto instrumentado y la pérdida del bienestar fetal; y aumenta las disfunciones del suelo pélvico.[1] Las fuentes vigentes la precisan:

- **No se hace de rutina.** La episiotomía selectiva redujo un 30% el trauma perineal grave frente a la rutinaria, sin cambiar la pérdida sanguínea, la puntuación de Apgar ni la infección.[5,6]
- **Indicaciones de la GPC:** periné corto, presentación de cara, compuesta o pélvica, distocia de hombros y parto instrumentado.[5]

- **Técnica: mediolateral**, con el consentimiento de la mujer y siempre con analgesia adecuada. Si la analgesia es local con lidocaína, la tabla de medicamentos de la GPC fija una dosis máxima de 4,5 mg/kg o 300 mg.[5]
- **Antibiótico:** si la episiotomía evoluciona sin complicaciones no se indica antibiótico.[5]
- **Violencia obstétrica:** la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la describe como una forma de violencia institucional y de género que incluye el abuso de la medicalización de los procesos naturales; una episiotomía sin indicación ni consentimiento se ajusta a esa descripción.[7]

Los desgarros que la episiotomía busca evitar se clasifican en cuatro grados (sección 8.2).[5]

5.4 Nacimiento de la cabeza

Durante la extensión, la cabeza se deja salir despacio y de preferencia entre contracciones. La rúbrica describe que la mano izquierda sujeta la cabeza, para controlar su salida y mantener la flexión, y la derecha, sobre el periné, ayuda a liberar la cara: frente, nariz, boca y mentón.[1,8] La maniobra de Ritgen modificada corresponde a este momento (sección 5.2).[5]

5.5 Rotación externa y circular de cordón

Después de que nace la cabeza se permite la **rotación externa**: la cabeza gira hacia el lado que tenía el occipucio, y la mano solo la acompaña en esa dirección.[1,8] Al terminar la rotación se revisa el cuello fetal en busca de **circular de cordón**:[1]

- **Circular laxa:** se desliza sobre la cabeza o se deja que el cuerpo nazca a través de ella.[11]
- **Circular apretada que no se puede reducir:** se pinza con dos pinzas y se corta entre ellas antes de continuar. La NOM-007 incluye la circular de cordón al cuello entre las indicaciones de pinzamiento inmediato.[6,11]

5.6 Hombros, cuerpo y oxitocina

1. **Hombro anterior:** con las palmas sobre ambos lados de la cabeza y el cuello fetal, sin tracción brusca, se hace un descenso suave hasta que el hombro anterior aparece bajo el pubis.[1]
2. **Oxitocina:** al salir el hombro anterior se indica la aplicación de **10 UI de oxitocina IM o IV**, que inicia el manejo activo del alumbramiento.[1,5,6]
3. **Hombro posterior:** con un movimiento hacia arriba se libera el hombro posterior.[1]
4. **Cuerpo:** una mano se desliza por la espalda del recién nacido mientras sale el resto del cuerpo, que nace con rapidez.[1,8]

5.7 Distocia de hombros

La distocia de hombros ocurre cuando, después de la salida de la cabeza, el hombro anterior queda atorado detrás del pubis.[8] La rúbrica pide nombrar dos maniobras: **McRoberts** y **presión suprapúbica**.[1] La secuencia de atención es:[12]

1. **Pedir ayuda** y anunciar la distocia; la mujer deja de pujar.
2. **Maniobra de McRoberts:** hiperflexión de los muslos de la madre sobre el abdomen, que aplana el sacro y amplía el estrecho superior.
3. **Presión suprapúbica:** un ayudante presiona justo por arriba del pubis, desde el lado en el que se encuentra la espalda fetal, mientras se mantiene la posición de McRoberts.
4. **Maniobras internas** si las anteriores fallan: extracción del brazo posterior y rotación interna de los hombros.
5. **No presionar el fondo uterino**, porque puede empeorar el impacto del hombro y romper el útero. La episiotomía puede dar espacio para las maniobras internas, pero no resuelve la obstrucción, que es ósea.

6. Recién nacido y cordón

6.1 Apego inmediato

El recién nacido se coloca sobre el abdomen de la madre para el **contacto piel con piel** dentro de la primera hora, porque aumentó la lactancia exclusiva al alta, al mes y hasta los 6 meses. Se omite si hay condiciones maternas desfavorables (desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón o paro cardiaco) o asfixia neonatal.[1,5] La NOM-007 fija el inicio de la lactancia dentro de los primeros 30 minutos de vida.[6]

6.2 Pinzamiento y corte del cordón

- **Pinzamiento tardío (la regla):** al menos 60 segundos después del nacimiento según la GPC, o entre 30 y 60 segundos según la NOM-007, con el recién nacido por debajo del nivel de la placenta. A término aumenta la hemoglobina del recién nacido y reduce a menos de la mitad la deficiencia de hierro entre los 3 y los 6 meses.[5,6]
- **Pinzamiento inmediato (la excepción):** según la GPC, ante desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardiaco materno o asfixia neonatal; según la NOM-007, ante madre Rh negativa no isoinmunizada, circular de cordón al cuello o sufrimiento fetal agudo.[5,6]
- **Madre Rh negativa:** la NOM-007 indica pinzar solo el extremo del cordón que corresponde al recién nacido, dejar libre el extremo placentario y evitar en lo posible la revisión de la cavidad uterina.[6]
- **Corte:** se colocan las dos pinzas y se corta entre ellas.[1]

6.3 Entrega al pediatra y registro

Después del corte se entrega el recién nacido al pediatra para los cuidados neonatales.[1] Se aplica **vitamina K, 1 mg IM**; no se aspiran de rutina la boca ni la nariz si el líquido amniótico es claro y el recién nacido respira, y el baño se pospone hasta las 24 horas.[5] Se registran el tipo de parto, la fecha y hora y las condiciones del recién nacido: sexo, edad gestacional, somatometría y dos valoraciones que conviene saber definir.[6]

- **Valoración de Apgar:** se hace al minuto y a los 5 minutos y califica de 0 a 2 cinco signos: la frecuencia cardiaca (ausente; menor de 100; mayor de 100), el esfuerzo respiratorio (ausente; regular o hipoventilación; bueno, con llanto fuerte), el tono muscular (flácido; alguna flexión de las extremidades; movimientos activos con buena flexión), la irritabilidad refleja (sin respuesta; llanto y alguna movilidad; llanto vigoroso) y el color (azul o pálido; cuerpo sonrosado con manos y pies azules; completamente sonrosado). La calificación de 7 o más se considera normal, y la de 6 o menos amerita atención especial; la de los 5 minutos califica el estado de salud del recién nacido.[6]
- **Valoración de Silverman-Anderson:** mide la dificultad respiratoria con cinco signos calificados de 0 a 2: los movimientos toracoabdominales, el tiraje intercostal, la retracción xifoidea, el aleteo nasal y el quejido espiratorio. Una puntuación mayor indica mayor dificultad respiratoria; la NOM-007 considera grave la superior a 5.[6]

7. Alumbramiento

7.1 Manejo activo y uterotónico

El **manejo activo del tercer periodo** se aplica a todas las mujeres, porque reduce la HPP grave y la necesidad de transfusión. Tiene tres componentes:[5,6]

- **Uterotónico:** oxitocina, **10 UI IM o IV** después del nacimiento del hombro anterior; es el de elección y reduce casi a la mitad la HPP de más de 500 mL. Si no hay oxitocina, se usa ergonovina, carbetocina o misoprostol.
- **Tracción controlada del cordón:** tracción suave y sostenida, que redujo ligeramente la pérdida sanguínea, acortó el tercer periodo y disminuyó la extracción manual de la placenta.
- **Masaje uterino** a través de la pared abdominal después de la expulsión.

La rúbrica califica la administración de 10 UI de oxitocina a la madre en el alumbramiento (criterio 18), además de la indicación con el hombro anterior (criterio 13).[1] La forma segura de cumplir ambos es anunciar en el criterio 13 “indico 10 UI de oxitocina IM con el hombro anterior” y en el 18 “verifico que se aplicaron las 10 UI de oxitocina del manejo activo”.

7.2 Signos de desprendimiento de la placenta

Antes de traccionar se comprueba que la placenta se haya desprendido y que el útero esté contraído. Los signos clásicos de desprendimiento son:[13,14]

- **Ahlfeld:** la pinza colocada en el cordón junto a la vulva desciende, porque el cordón se alarga.
- **Schröder:** el útero asciende por arriba del ombligo, se vuelve globoso y se desvía a la derecha.
- **Küstner:** al presionar por arriba del pubis, el cordón no asciende si la placenta ya se desprendió.
- **Strassmann:** si la placenta sigue adherida, la presión sobre el fondo uterino se transmite al cordón.
- **Salida súbita de sangre** por la vulva.

7.3 Extracción de la placenta

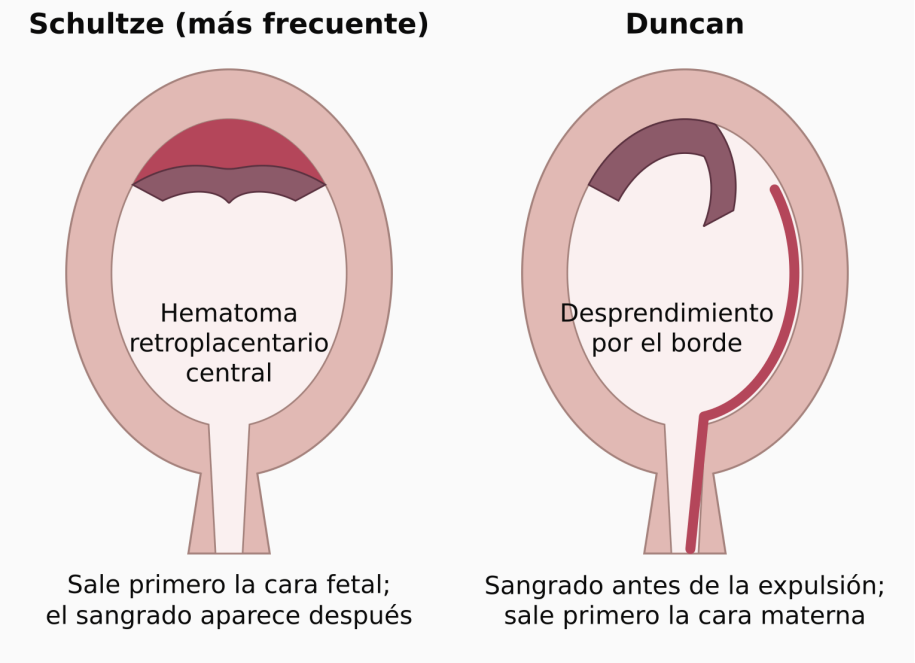
Con signos de desprendimiento, se hace una tracción leve y sostenida del cordón mientras la otra mano, por arriba del pubis, empuja el útero hacia arriba para sostenerlo (contratracción, maniobra de Brandt-Andrews), lo que protege contra la inversión uterina. Cuando la placenta aparece en la vulva, se sujeta con ambas manos y se gira sobre su eje para enrollar las membranas y extraerlas completas.[1,5,14]

Placenta retenida. Si la placenta no sale 30 minutos después del nacimiento con manejo activo, se considera retenida y se refiere su manejo al equipo de obstetricia.[15] La revisión manual de la cavidad uterina no se hace de rutina, porque es el principal factor de endometritis posparto; se reserva para la sospecha de restos, por personal calificado, con analgesia y antisepsia.[5,6]

7.4 Mecanismos de Schultze y de Duncan

La placenta se desprende por uno de dos mecanismos, que se distinguen por el sitio donde empieza el desprendimiento, el momento del sangrado y la cara que sale primero:[1,13]

- **Schultze (alrededor del 80%):** el desprendimiento empieza en el **centro** de la placenta. La sangre se acumula detrás de ella y forma un **hematoma retroplacentario central** que la empuja y la invierte “en paraguas”, de modo que sale primero la **cara fetal**, brillante y cubierta por las membranas. Como la sangre queda contenida en el hematoma, **el sangrado aparece después** de la expulsión.
- **Duncan (alrededor del 20%):** el desprendimiento empieza por un **borde**, no se forma un hematoma central y la sangre escurre hacia el cuello, de modo que **el sangrado aparece antes** de la expulsión. La placenta sale de canto, con la **cara materna** por delante, en la que se ven los cotiledones.



Esquema generado de los mecanismos de desprendimiento de la placenta en un corte del útero después del nacimiento. Izquierda, Schultze: el desprendimiento empieza en el centro, con un hematoma retroplacentario central (rojo); la placenta sale invertida, con la cara fetal por delante, y el sangrado aparece después. Derecha, Duncan: el desprendimiento empieza por un borde y la sangre escurre hacia el cuello antes de que salga la placenta, que se expulsa por el borde con la cara materna por delante. No reproduce un caso real.[13]

7.5 Revisión de la placenta

La placenta y las membranas se revisan en el riñón para comprobar que están **completas**, porque un fragmento retenido puede causar hemorragia o infección.[5,6]

- **Cara materna:** cotiledones completos, sin zonas faltantes ni bordes desgarrados. La rúbrica espera que se digan de 15 a 20 cotiledones; el número que dan los textos varía, de modo que lo que se califica en la práctica es comprobar que no falte ninguno.[1]
- **Cara fetal:** brillante, cubierta por el amnios, con los vasos que convergen en la inserción del cordón.
- **Cordón:** tres vasos, dos arterias y una vena.
- **Membranas:** completas.

8. Cierre de la atención

8.1 Desecho de la placenta y de los demás residuos

La placenta es un **residuo patológico** según la NOM-087, y se coloca en una **bolsa de polietileno amarilla**.[16,17] Los demás residuos del parto se separan en el mismo momento, cada uno en su envase:[16,17]

- **Residuos patológicos (placenta):** bolsa de polietileno amarilla.
- **Residuos no anatómicos (gasas y compresas con sangre):** bolsa de polietileno roja.
- **Punzocortantes (agujas de sutura y hojas de bisturí):** recipiente rígido de polipropileno rojo.
- **Sangre líquida recolectada:** recipiente hermético rojo.

8.2 Revisión del canal del parto

Después del alumbramiento se revisa el canal del parto (cuello, vagina, periné y región perianal) para descartar desgarros o lesiones, y se comprueba que el útero esté contraído, que el sangrado sea escaso y que los signos vitales sean normales.[1,6] Si hay un desgarro, se dice su grado según las estructuras afectadas:[5,18]

- **Grado I:** solo la piel del periné; el RCOG incluye también la lesión aislada de la mucosa vaginal.
- **Grado II:** los músculos del periné, sin daño del esfínter anal.
- **Grado III A:** menos del 50% del espesor del esfínter anal externo.
- **Grado III B:** más del 50% del espesor del esfínter anal externo.
- **Grado III C:** los esfínteres anales externo e interno.
- **Grado IV:** los esfínteres externo e interno y la mucosa anal.

El RCOG recomienda asignar el grado mayor cuando hay duda entre dos grados de un desgarro de tercer grado. La reparación de los desgarros de tercer y cuarto grado corresponde a un médico con experiencia.[5,18]

8.3 Si el sangrado es abundante

La GPC de hemorragia posparto define la HPP como la pérdida de 1000 mL o más o cualquier pérdida con signos de hipovolemia; el glosario de la GPC del parto la sitúa en 500 mL o más.[5,19] En la estación, un útero blando con sangrado que no cede obliga a actuar de inmediato:[19,20]

1. **Pedir ayuda** y anunciar la hemorragia.
2. **Aplicar al mismo tiempo el paquete de primera respuesta de la OMS:** masaje uterino, uterotónicos, ácido tranexámico, líquidos intravenosos y exploración para encontrar la causa.
3. **Buscar la causa con las 4 T: tono** (atonía, la causa más frecuente), **trauma** (desgarros, hematomas, ruptura o inversión uterina), **tejido** (cotiledones o membranas retenidos) y **trombina** (coagulopatía).

Por eso la revisión completa de la placenta y del canal del parto no es un trámite: son la búsqueda de dos de las cuatro causas.[19]

8.4 Vigilancia del puerperio inmediato

La mujer se revisa cada 15 minutos durante la primera hora y cada 30 minutos hasta las 2 horas: FC, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, sangrado transvaginal, tono y altura del útero y micción espontánea; si hubo episiotomía, se revisa la sutura en busca de hemorragia o hematoma.[5,6] Completan la atención inmediata:[5,6]

- **Sin antibiótico profiláctico** después de un parto sin complicaciones.
- **Profilaxis anti-D:** a la madre Rh negativa con recién nacido Rh positivo y prueba de Coombs indirecta negativa se le aplican 300 µg de inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas.
- **Anticoncepción:** se valora un método, como el dispositivo intrauterino posparto, si se completaron la consejería y el consentimiento informado.
- **Signos de alarma:** antes del egreso se enseñan a la madre los propios (fiebre, hemorragia y cefalea persistente) y los del recién nacido.

9. Escenarios para practicar

Los escenarios se ensayan en voz alta, anunciando cada paso, en el orden de la sección 1.2.

Escenario 1. Parto eutócico completo

Planteamiento. Primigesta de 39 semanas con dilatación y borramiento completos, presentación cefálica en descenso y FCF de 140 por minuto.

Respuesta esperada:

1. **Preparación estéril:** gorro, cubrebocas y botas; lavado quirúrgico en tres tiempos; bata sin sacar las manos de los puños; guantes del número correcto con técnica cerrada.
2. **Campo:** material completo (dos pinzas, riñón, gasa montada, corte y hemostasia, oxitocina preparada); presentación y explicación a la mujer; asepsia en calzoncillo; campo inferior impermeable, abdominal y pierneras.
3. **Expulsivo:** FCF al término de cada contracción; pujo con la contracción; protección del periné con maniobra de Ritgen modificada o técnica finlandesa; sin episiotomía si no hay indicación; cabeza con salida lenta; rotación externa y búsqueda de circular; hombro anterior con descenso suave y anuncio de 10 UI de oxitocina IM; hombro posterior hacia arriba; deslizar la mano por la espalda.
4. **Recién nacido:** sobre el abdomen materno; pinzamiento a los 60 segundos, corte entre dos pinzas y entrega al pediatra; Apgar al minuto y a los 5 minutos.
5. **Alumbramiento:** signos de desprendimiento; tracción controlada con contratracción suprapúbica; torsión de las membranas; revisión de la placenta, de

los cotiledones, de los tres vasos del cordón y de las membranas; mecanismo observado (Schultze o Duncan).

6. **Cierre:** placenta en bolsa amarilla y gasas en bolsa roja; revisión del canal y del tono uterino; vigilancia cada 15 minutos.

Escenario 2. Circular de cordón apretada

Planteamiento. Tras la rotación externa se palpa una circular de cordón al cuello que no se puede deslizar sobre la cabeza.

Respuesta esperada: intentar deslizarla sobre la cabeza o los hombros; si no es posible, colocar dos pinzas, cortar entre ellas y continuar con los hombros. Anunciar que la circular es una indicación de pinzamiento inmediato según la NOM-007.

Escenario 3. Distocia de hombros

Planteamiento. Después de la salida de la cabeza, el descenso suave no libera el hombro anterior.

Respuesta esperada: anunciar la distocia y pedir ayuda; indicar a la madre que deje de pujar; maniobra de McRoberts con presión suprapúbica desde el lado de la espalda fetal; si falla, maniobras internas (brazo posterior o rotación de los hombros). No presionar el fondo uterino.

Escenario 4. Sangrado antes de la salida de la placenta

Planteamiento. A los 10 minutos del nacimiento hay salida de sangre por la vulva y el cordón desciende.

Respuesta esperada: son signos de desprendimiento (salida súbita de sangre y signo de Ahlfeld) y sugieren un mecanismo de Duncan. Tracción controlada con contratracción, extracción con torsión de las membranas, revisión de la placenta, masaje uterino y vigilancia del sangrado. Si la placenta no sale a los 30 minutos con manejo activo, se considera retenida.

Escenario 5. Sangrado después del alumbramiento

Planteamiento. Diez minutos después de la expulsión de la placenta, el útero está blando, por arriba del ombligo, y el sangrado no cede. “FC de 112 por minuto, presión arterial de 96/60 mmHg.”

Respuesta esperada: reconocer una HPP con signos de hipovolemia; pedir ayuda; masaje uterino y uterotónico, ácido tranexámico y líquidos intravenosos al mismo tiempo; buscar la causa con las 4 T, empezando por el tono (útero blando), y revisar de nuevo la placenta (tejido) y el canal del parto (trauma).

10. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cuáles son los tiempos del lavado quirúrgico? Primero, de las uñas a unos 5 cm por arriba del codo; segundo, hasta la unión del tercio medio con el proximal del antebrazo; tercero, hasta la muñeca.[2]

¿Qué es la técnica cerrada de guantes? Colocar los guantes sin que las manos salgan de los puños de la bata.[4]

¿Cuánto dura normalmente el expulsivo? Su mediana es de unos 50 minutos en las nulíparas y de unos 20 en las multíparas; el nacimiento suele ocurrir en las 3 horas siguientes a la dilatación completa en el primer parto y en 2 horas en los demás.[8,9]

¿Qué maniobras protegen el periné? La de Ritgen modificada y la técnica finlandesa, con compresas calientes y protección manual.[1,5,10]

¿Se hace episiotomía de rutina? No: la selectiva reduce el trauma perineal grave. Se considera ante periné corto, presentación de cara, compuesta o pélvica, distocia de hombros o parto instrumentado, con técnica mediolateral, consentimiento y analgesia.[5]

¿Se puede presionar el fondo uterino? No: la maniobra de Kristeller está prohibida por la NOM-007.[6]

¿Cuándo se aplica la oxitocina y en qué dosis? 10 UI IM o IV al salir el hombro anterior.[5,6]

¿Qué maniobras se usan en la distocia de hombros? McRoberts y presión suprapúbica; si fallan, maniobras internas. Nunca presión fúndica.[1,12]

¿Cuándo se pinza el cordón? De forma tardía, a los 60 segundos o más (de 30 a 60 según la NOM-007), salvo indicaciones de pinzamiento inmediato.[5,6]

¿Qué valora el Apgar y cuándo se hace? Frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color, al minuto y a los 5 minutos; 7 o más es normal.[6]

¿Cuáles son los componentes del manejo activo del alumbramiento? Uterotónico, tracción controlada del cordón y masaje uterino.[5,6]

¿Cuáles son los signos de desprendimiento de la placenta? Ahlfeld, Schröder, Küstner, Strassmann y la salida súbita de sangre.[13]

¿Qué diferencia hay entre Schultze y Duncan? Schultze (80%) empieza en el centro, con hematoma central, sale la cara fetal y el sangrado es posterior; Duncan (20%) empieza en el borde, sangra antes y sale la cara materna.[1,13]

¿Cuántos cotiledones tiene la placenta? La rúbrica espera de 15 a 20; lo importante es comprobar que estén completos.[1]

¿En qué bolsa se desecha la placenta? En la bolsa amarilla de residuos patológicos; las gasas con sangre van en la bolsa roja.[16,17]

¿Cuándo se considera retenida la placenta? Si no sale 30 minutos después del nacimiento con manejo activo.[15]

¿Cuáles son las causas de la HPP? Las 4 T: tono, trauma, tejido y trombina; la atonía es la más frecuente.[19]

11. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

La rúbrica califica una respuesta concreta. Cuando difiere de la evidencia vigente, lo más seguro es decir primero lo que pide la rúbrica y añadir la precisión en la misma frase.[1,5,6,7]

- **Criterio 9 (tipo de episiotomía).** La rúbrica la recomienda lateral; la GPC indica la mediolateral. Se dice: “Episiotomía mediolateral, solo con indicación, con consentimiento y con analgesia”.
- **Criterio 9 (indicaciones).** La rúbrica incluye la pérdida del bienestar fetal, que la GPC no enumera; las indicaciones de la GPC incluyen además la presentación compuesta o pélvica y la distocia de hombros. Se dan las indicaciones de la rúbrica y se añaden las de la GPC.
- **Criterio 9 (suelo pélvico).** La rúbrica afirma que la episiotomía aumenta las disfunciones del suelo pélvico; las fuentes revisadas fundamentan la política selectiva en la reducción del trauma perineal grave. Se dice: “La rutinaria no protege el periné; la selectiva reduce el trauma grave”.
- **Criterio 9 (violencia obstétrica).** La rúbrica dice que en mujeres sanas se considera violencia obstétrica; la CNDH la describe como abuso de la medicalización, y la NOM-007 y la GPC prohíben la episiotomía de rutina. Se dice así.
- **Criterio 16 (cordón).** La rúbrica acepta el pinzamiento “tardío o inmediato”; el tardío es la regla y el inmediato tiene indicaciones concretas. Se dice: “Pinzamiento tardío, salvo indicación de inmediato”.
- **Criterio 18 (uterotónico).** La rúbrica lo sitúa en el alumbramiento; la GPC y la NOM-007 aplican la oxitocina con el hombro anterior. Se anuncia en el criterio 13 y se confirma en el 18.
- **Criterio 19 (Schultze y Duncan).** Las proporciones de 80% y 20% proceden de textos docentes. Se dan como aproximadas.

12. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Analgesia epidural:** con ella, la GPC recomienda retrasar el pujo de 1 a 2 horas.[5]

- **Reparación de los desgarros y de la episiotomía:** la técnica de sutura de los desgarros de tercer y cuarto grado corresponde a un médico con experiencia.[5]
- **Maniobras internas de la distocia de hombros:** extracción del brazo posterior y rotación interna de los hombros; las guías actuales las describen por su función más que por sus epónimos.[12]
- **Maniobra en voltereta** en la circular de cordón apretada: mantiene la cabeza junto al periné mientras nace el cuerpo; no figura en las guías.[11]
- **Uterotónicos alternativos y tratamiento escalonado de la HPP:** carbetocina, ergonovina y misoprostol; su elección y los pasos siguientes se tratan en el tema de hemorragia.[5,19]

13. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 a 3):** hacer en voz alta el lavado, la bata y los guantes sin contaminarse, enumerar el material y practicar la explicación a la mujer.
- **Día 1, tarde (secciones 4 y 5):** narrar el expulsivo completo con las maniobras de protección, la episiotomía y la distocia de hombros.
- **Día 1, noche (sección 6):** explicar el apego, las indicaciones de pinzamiento tardío e inmediato y las valoraciones de Apgar y de Silverman-Anderson.
- **Día 2, mañana (secciones 7 y 8):** recitar los signos de desprendimiento, Schultze y Duncan, la revisión de la placenta, la separación de los residuos, los grados de los desgarros y las 4 T.
- **Día 2, tarde (secciones 9 y 10):** ensayar los cinco escenarios con cronómetro.
- **Día 2, noche (Tabla 1 y sección 11):** repaso final de los 21 criterios y de las precisiones.

Conviene ensayar la secuencia completa con las manos, porque los criterios de técnica estéril se pierden por un movimiento y no por un concepto.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 8: Trabajo de parto (21 criterios; acredita con 15). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Técnicas de lavado quirúrgico de manos por arrastre y de preparación quirúrgica de manos. México: UNAM; 2019.
3. [cita] World Health Organization. Global guidelines for the prevention of surgical site infection. 2.ª ed. Geneva: World Health Organization; 2018.
4. [cita] Enfermería ante la higiene, asepsia y esterilidad en cirugía oftalmológica. Revista Electrónica de Portales Médicos; sin fecha.
5. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. Guía de Práctica Clínica: Guía de Evidencias y Recomendaciones IMSS-052-19. México: CENETEC; 2019.
6. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016. Fuente del usuario del tema 3.
7. [cita] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. México: CNDH; 2017.
8. [cita] Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM. Trabajo de parto normal. En: Williams Obstetricia. 26.ª ed. México: McGraw Hill; 2022. Capítulo 22.
9. [cita] World Health Organization. WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018.
10. [cita] Poulsen MØ, Madsen ML, Skriver-Møller AC, Overgaard C. Does the Finnish intervention prevent obstetric anal sphincter injuries? A systematic review of the literature. BMJ Open. 2015;5(9):e008346.
11. [cita] Hutchon DJR. Management of the nuchal cord at birth. J Midwifery Reprod Health. 2013;1(1):4-6.
12. [cita] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Shoulder dystocia. Green-top Guideline No. 42. Londres: RCOG; 2012.
13. [cita] Asistencia obstétrica del alumbramiento fisiológico. Revista Electrónica de Portales Médicos; sin fecha.
14. [cita] Brandt-Andrews maneuver. En: Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. Filadelfia: F. A. Davis; edición en línea.
15. [cita] National Institute for Health and Care Excellence. Intrapartum care. NICE guideline NG235. Londres: NICE; 2023.

16. [cita] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Diario Oficial de la Federación, 17 de febrero de 2003.
17. [cita] Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Tríptico de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI). México: UNAM; sin fecha.
18. [cita] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The management of third- and fourth-degree perineal tears. Green-top Guideline No. 29. Londres: RCOG; 2015.
19. [cita] Secretaría de Salud. Prevención y manejo de la hemorragia postparto. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones SS-103-21. México: CENETEC; 2021. Fuente del usuario del tema 7.
20. [cita] World Health Organization. WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2023.